

Pruebas funcionales, instrumentos y escalas de evaluación

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Seleccionar y documentar mediciones reproducibles de dolor, movilidad, fuerza, marcha y función según el caso.

2. Alcance y condiciones de uso

No corresponde a pruebas psicológicas. Los instrumentos protegidos o comerciales se usan con permisos; no se reproducen escalas completas sin verificar licencia y versión.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Responsable clínico	Seleccionar equipo según indicación y comprobar uso seguro.
Proveedor técnico competente	Ejecutar mantenimiento, medición y evaluación trazables.
Operador entrenado	Revisar apertura, vigilar y retirar fallas de uso.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Definir la pregunta funcional y elegir una medida adecuada a población e idioma

Definir la pregunta funcional y elegir una medida adecuada a población e idioma. Revisar evidencia, instrucciones, licencia, validez y limitaciones antes de adoptarla.

2. Identificar el equipo de medición, su estado y preparación

Identificar el equipo de medición, su estado y preparación. Estandarizar posición, explicación, demostración y unidades para facilitar comparación entre sesiones.

3. Verificar seguridad de la prueba, ayudas y capacidad de comprensión

Verificar seguridad de la prueba, ayudas y capacidad de comprensión. No realizar pruebas máximas o de riesgo sin competencia, indicación y condiciones suficientes.

4. Registrar resultados originales, método, apoyo y síntomas

Registrar resultados originales, método, apoyo y síntomas. Diferenciar observación, dato medido e interpretación; no calcular resultados inexistentes ni trasladar normas de otra población.

5. Repetir en condiciones comparables y analizar cambio junto con objetivos del paciente

Repetir en condiciones comparables y analizar cambio junto con objetivos del paciente. No utilizar un punto de corte aislado para negar atención o reemplazar razonamiento clínico.

6. Revisar instrumento ante cambios, sesgos o errores de uso

Revisar instrumento ante cambios, sesgos o errores de uso. Formar al personal, conservar referencia y decidir qué medida integra cada ruta clínica.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Técnica reproducible y unidades visibles.

Resultados originales conservados.

Biblioteca de instrumentos autorizados.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.3 y 11.3.1.15-19: dotación según procedimientos documentados y modalidad. Manual, mantenimiento y metrología corresponden al equipo real.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Instrumento y versión	
Fuente y permiso	
Población	
Equipo y código	
Método y posición	
Fecha y evaluador	
Resultado y unidad	
Síntomas o apoyo	
Interpretación	
Reevaluación	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Ejercicio profesional

Ley 528 de 1999, artículos 1-3 y 27, principios, competencias y consentimiento previo. El contenido exige evaluación integral y fundamento científico; no garantiza resultados ni amplía competencias por tener un formato.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66199>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576